

Выделите основных возбудителей анаэробной газовой гангрены: {

- ~ Pnevmonococc
 - ~ Sthreptococc
 - = Clostridium perfringes, hystolyticus, vibriion septicus, cl.ocdematiens
 - ~ палочка Коха
 - ~ Cl.tetani
- }

Длительность инкубационного периода при клостридиальной анаэробной инфекции составляет: {

- ~ 3-4 дня
 - ~ 5-10 дней
 - ~ 15-30 дней
 - = 1-2 дня
 - ~ 1-6 месяцев
- }

Укажите специфический симптом клостридиальной анаэробной инфекции: {

- = симптом «наждачки»
 - ~ симптом «лигатуры»
 - ~ обильное раневое отделяемое
 - ~ отсутствие болей в области повреждения
 - ~ образование пустул на кожных покровах
- }

Чаще всего анаэробная инфекция локализуется на: {

- ~ голове, шеи
 - = конечностях
 - ~ промежности
 - ~ туловище
 - ~ в легком
- }

Назовите наиболее частые причины, способствующие развитию анаэробной инфекции: {

- = шок, анемия
 - ~ ожирение
 - ~ утомление
 - ~ гипотония
 - ~ пожилой возраст
- }

Газовая гангрена чаще встречается после: {

- ~ ожогов
- ~ резанных ран

- ~ закрытых травм
- = огнестрельных повреждений
- ~ операционных ран
- }

Профилактическая доза противогангренозной сыворотки составляет: {

- ~ 1000 АЕ
- ~ 2000 АЕ
- ~ 3000 АЕ
- = 30000 АЕ
- ~ 40000 АЕ
- }

Лечебная доза противогангренозной сыворотки составляет: {

- ~ 5000 АЕ
- ~ 50000 АЕ
- ~ 100000 АЕ
- = 150000 АЕ
- ~ 200000 АЕ
- }

Специфическое лечение газовой гангрены заключается в введении: {

- ~ антибиотиков
- ~ противодифтерийной сыворотки
- ~ гаммаглобулина
- = противогангренозной сыворотки
- ~ вливании физиологического раствора
- }

По патологоанатомической классификации различают следующие формы газовой гангрены: {

- ~ молниеносная форма
- ~ костная форма
- = эмфизематозная, отечная, флегмонозная, некротическая
- ~ ЭПИ и субфасциальная
- ~ коматозная
- }

По клинической классификации различают следующие формы газовой гангрены:

- {
- = острая молниеносная
- ~ клостридиальный миелонекроз
- ~ синхронная
- ~ подострая
- ~ вялотекущая
- }

Причины интоксикации при газовой гангрене следующие: {

- ~ нарушение обмена
 - = всасывание продуктов некроза тканей и клостридиальных токсинов
 - ~ нарушение микроциркуляции
 - ~ кровопотеря
 - ~ жировая эмболия
- }

Основными местными признаками газовой гангрены является: {

- ~ наличие воспалительной реакции в тканях
 - ~ обильное раневое отделяемое
 - ~ лимфангоит
 - ~ бактериемия
 - = подкожная эмфизема
- }

Для срочной диагностики анаэробной инфекции решающее значение имеет:

- ~ общий анализ крови
 - ~ общий анализ мочи
 - ~ реакция Видаля
 - = бактериоскопия мазков-отпечатков из раны
 - ~ реакция Вассермана
- }

При анаэробной инфекции для промывания раны наиболее целесообразно использовать: {

- ~ растворы солей тяжелых металлов
 - ~ галоиды
 - = препараты группы окислителей
 - ~ антибиотики
 - ~ препараты из группы красителей
- }

При анаэробной инфекции применяют следующие оперативные методы: {

- ~ экзартикуляция пальцев
 - ~ экономное рассечение тканей в области раны
 - ~ дренирование ран
 - = лампасные разрезы с иссечением некротизированных мышц
 - ~ минимальная ампутация конечности
- }

Для промывания ран при газовой гангрене используется: {

- ~ физиологический раствор
- ~ новокаин
- = перекись водорода
- ~ раствор глюкозы

~ дистиллированная вода
}

Гнилостная инфекция развивается при наличии: {

~ пневмококков
~ палочки Леффлера
= анаэробных бактерий
~ палочки Коха
~ гонококков
}

При наличии каких бактерий развивается гнилостная инфекция: {

~ пневмококка
= *B. putrificans*, *protens*, *vulgaris*, *E. Coli*
~ золотистого стафилококка
~ палочки столбняка
~ стрептококка
}

У больных с анаэробной инфекцией возможны следующие осложнения: {

= кровотечения, вторичная анемия
~ кератит, инсульт
~ жировая, воздушная эмболия
~ амилоидоз внутренних органов
~ рецидив анаэробной инфекции
}

Противоэпидемические мероприятия при анаэробной инфекции заключаются в: {

= изоляции больных, выделении отдельного медперсонала
~ выделении лишь отдельных предметов туалета
~ белье и халаты медперсонала подвергаются многократной стирке
~ белье и халаты замачивают в 0,5 растворе хлорамина на 1 час и списывают
~ повторном использовании перевязочного материала после стирки
}

Местные изменения при гнилостной инфекции характеризуются: {

~ воспалением
~ расплавлением тканей
~ лимфангоитом
~ отсутствием отделяемого
= наличием специфического запаха отделяемого
}

Принципы общего лечения гнилостной инфекции заключаются в: {

~ кварцевании раневых поверхностей
= применении препаратов группы метронидазола, иммуностимуляции

- ~ рентгенотерапии
 - ~ лимфостимуляции
 - ~ антибактериальной терапии препаратами группы пенициллина
- }

Для антибактериальной терапии при неклостридиальной гнилостной инфекции назначают следующие препараты: {

- ~ гентамицин
 - = клион, метрогил, тиенам, клиндомицин
 - ~ антисептики группы красителей
 - ~ пенициллин
 - ~ фурадонин, сульфадимизин
- }